Sistema de Turnos Online para una Red de Clínicas

a) Fase de Idea

Actualmente, la gestión de turnos únicamente por teléfono genera largas esperas para los pacientes, sobrecarga al personal de recepción, errores en las agendas y pérdida de turnos. Esto provoca reclamos frecuentes y reduce la eficiencia operativa de las cinco sedes.

b) Fase de Prefactibilidad

Alternativas de solución:

- Desarrollar un sistema web propio para solicitar, cancelar y reprogramar turnos.
- Implementar un bot de WhatsApp que permita gestionar turnos automáticamente.
- Contratar un sistema de turnos existente tipo SaaS y adaptarlo a las necesidades de la red.

Preguntas de prefactibilidad:

- ¿Cuál es el costo aproximado de implementación y mantenimiento de cada alternativa?
- ¿Cuánto tiempo llevaría poner en funcionamiento cada opción?
- ¿Puede integrarse con las agendas, sistemas y forma de trabajo actual de las cinco sedes?

c) Fase de Factibilidad

Estudio de mercado: analizar si los pacientes utilizarían canales digitales y cuáles prefieren. Se usarían fuentes primarias, como encuestas a pacientes y personal, y fuentes secundarias, como estadísticas y estudios sobre digitalización en salud.

Estudio técnico: revisar infraestructura, conectividad, sistemas actuales, integración entre sedes, seguridad y protección de datos. Se usarían fuentes primarias mediante relevamientos con el personal técnico y proveedores, y secundarias mediante documentación técnica.

Estudio económico: calcular la inversión inicial, costos de mantenimiento, licencias, capacitación y el ahorro esperado por reducción de horas de recepción, errores y turnos perdidos. Se usarían fuentes primarias, como cotizaciones y costos internos, y secundarias, como precios de mercado.

d) Proyecto Ejecutivo

- Diseño detallado del sistema: pantallas, flujos para solicitar, cancelar y reprogramar turnos, y roles de pacientes, médicos y recepción.
- Arquitectura y especificación técnica: tecnologías, base de datos, integraciones, infraestructura, seguridad y forma de despliegue.
- Cronograma de trabajo y criterios de aceptación para validar que cada funcionalidad cumpla con lo requerido.

e) Riesgos en Ejecución y Puesta en Marcha

Riesgo en Ejecución: que la integración con las agendas y sistemas existentes sea más compleja de lo previsto.
Mitigación: realizar pruebas de integración desde las primeras etapas, trabajar con datos de prueba de las distintas sedes y validar progresivamente cada integración.

Riesgo en Puesta en marcha: que aparezcan errores en el uso real o que pacientes y recepcionistas tengan dificultades para adaptarse al nuevo sistema.

Mitigación: realizar un lanzamiento piloto en una sede, capacitar al personal, mantener soporte reforzado durante los primeros días y desplegar luego la solución de forma progresiva en las demás sedes.